

06_Testlabor_Chat.txt

Testlabor Bildspur, Export vom 8. Oktober 2026. Bezug BS-2026-219.

05.10.2026 08:40, Otilie: S17 hat keinen Marker. In der vollständigen Serie ist die Referenzauffälligkeit sichtbar.

05.10.2026 08:43, Hanno: Damit ist nicht alles gelöscht. Bitte im Bericht sauber zwischen Anzeige und Speicherung unterscheiden.

05.10.2026 08:47, Berfin: Ich zähle drei erkannte Referenzfälle, einen übersehenen und drei zusätzliche Marker in unauffälligen Serien.

05.10.2026 08:50, Otilie: Richtig. Das ist kein repräsentativer Diagnostiktest. Dafür brauchen wir ein anderes Studiendesign.

06.10.2026 11:04, Livia: Wir können zuerst alle Bilder öffnen und die Markierungen danach einblenden. Noch kein ausgelieferter Stand.

06.10.2026 11:09, Hanno: Bitte Version und Testdatum nennen, sobald es soweit ist. Wir ändern bis dahin nichts im Produktivviewer.

07.10.2026 15:20, Berfin: Die Notfallfunktion taucht im Verkaufsprospekt auf. Ist sie in unseren Konten aktiv?

07.10.2026 15:24, Livia: Nein. Eigenes Projekt, kein Teil dieses Labors.

08.10.2026 09:15, Otilie: Ich liefere noch die medizinische Einschätzung zu den Folgen. Allein meine spätere Unterschrift verhindert keinen übersehenen Befund.

08.10.2026 09:19, Hanno: Danke. Der rechtliche Entwurf muss diese offene Frage sichtbar lassen.

01_Auftrag.eml

Von	"Dr. Hanno Wölfel" <hanno.woelfel@morgenhoehe.example>
An	"Dr. Salome Fritsch" <salome.fritsch@kanzlei-fritsch.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 09:20:00 +0200
Betreff	Bitte Bildspur Produktpfad und geplanten Einsatz getrennt prüfen

Sehr geehrte Frau Dr. Fritsch,

bitte erstellen Sie einen ausformulierten Vermerk zur Hochrisikoeinstufung unserer geplanten Bildassistenz. Der Hersteller spricht von Komfort, nennt in seiner Produktbeschreibung aber auch diagnostische Unterstützung. Den Laborbericht S17 finden Sie anbei. Unser internes Word-Dokument ist nur ein Arbeitsentwurf und soll durch Ihre Prüfung weitergeführt werden.

Wir brauchen insbesondere eine saubere Trennung zwischen der alten Archivfunktion, der neuen Bildassistenz und der nur besprochenen Notfalloption. Bitte prüfen Sie die Produktvoraussetzungen einschließlich der Frage, was der Hinweis auf menschliche Befundung tatsächlich trägt. Sagen Sie uns auch, welche konkreten Unterlagen wir noch anfordern müssen; eine umfassende technische Zertifizierung ist nicht Ihr Auftrag.

Wir planen einen Start im Januar 2027, haben ihn jedoch noch nicht freigegeben. Es gibt derzeit keine echten Patientendaten in der Testumgebung. Bitte erstellen Sie ein getrenntes Anbieteranschreiben und eine kurze interne Entscheidungsvorlage. Nichts soll bereits versandt, gemeldet oder bestellt werden. Über den weiteren Umfang entscheiden wir nach der Projektbesprechung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Hanno Wölfel

04_Vertriebsargument.eml

Von	Ottmar Seidel <ottmar.seidel@bildspur.example>
An	"Dr. Hanno Wölfel" <hanno.woelfel@morgenhoehe.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 14:35:00 +0200
Betreff	Komfortfunktion und persönliche Befundung

Sehr geehrter Herr Dr. Wölfel,

aus Vertriebsicht soll die Software vor allem Zeit beim Öffnen von Bildserien sparen. Sie unterschreibt nichts und ordnet keine Behandlung an. Ich hatte deshalb vorgeschlagen, den Ablauf als bloße Vorbereitung zu betrachten. Ob die neueren Sicherheitsvorschriften der KI-Verordnung hierzu eine genauere Einordnung verlangen, habe ich noch nicht mit unserer Rechtsabteilung abgestimmt.

Unser Qualitätsmanagement ist ausgebaut, und wir arbeiten mit externen Prüfern zusammen. Daraus wollte ich keine Aussage ableiten, dass bereits jede neue Version ein eigenes Systemzertifikat erhalten hätte. Frau Dr. Knörlein wird Ihnen den tatsächlichen Stand der Produktunterlagen gesondert mitteilen. Bitte legen Sie meiner Nachricht keine Nummer einer benannten Stelle oder eine bereits bestehende Produktzulassung zugrunde.

Die auf der Messe gezeigte Notfallpriorisierung war eine Entwicklungsansicht. In Ihren Testkonten ist sie nicht vorhanden. Eine Nutzung in der Notaufnahme würde ein eigenes Projekt erfordern. Für Ihre Entscheidung stelle ich gern einen Termin mit der Produktverantwortlichen und der klinischen Ansprechpartnerin ein.

Mit freundlichen Grüßen
Ottmar Seidel

08_Testdaten.eml

Von	Berfin Degenhardt <berfin.degenhardt@morgenhoehe.example>
An	"Dr. Hanno Wölfel" <hanno.woelfel@morgenhoehe.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 10:10:00 +0200
Betreff	Arbeitsmappe zum synthetischen Test und zu den Angebotskosten

Guten Tag Herr Dr. Wölfel,

anbei die Excel-Datei. Die Kennzahlen beziehen sich nur auf den kleinen synthetischen Laborversuch. Vierzig Serien mit vier Referenzauffälligkeiten erlauben keine Aussage über die klinische Sensitivität im Patienteneinsatz. Ich habe deshalb Zählwerte und Quotienten benannt und auf eine grüne Sicherheitsampel verzichtet. Bitte lassen Sie auch die juristische Einordnung nicht aus einer Prozentzahl ableiten.

Der Fehler S17 ist weiterhin offen. Ein zusätzlicher Test soll mit geänderter Startansicht durchgeführt werden; die Daten in der Arbeitsmappe zeigen noch die bisherige Version. Die Kostenseite entspricht dem Angebot vom 7. Oktober und darf nicht als bereits fällige Verbindlichkeit in die Buchhaltung übernommen werden.

Die klinische Leiterin konnte noch nicht schriftlich bestätigen, welche Folgen ein übersehener Befund im gesamten vorgesehenen Einsatzspektrum haben könnte. Diese Frage betrifft aus meiner Sicht die Produktbeschreibung und nicht nur die Schulung. Bitte nehmen Sie sie in das Anbieteranschreiben beziehungsweise die fachliche Nachforderung auf.

Freundliche Grüße
Berfin Degenhardt

12_Hersteller_Nachtrag.eml

Von	"Dr. Livia Knörlein" <livia.knoerlein@bildspur.example>
An	"Dr. Hanno Wölfel" <hanno.woelfel@morgenhoehe.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 17:45:00 +0200
Betreff	Neue Gesamtansicht ist erst ein Vorschlag

Sehr geehrter Herr Dr. Wölfel,

wir können die vollständige Bildserie vor den Markierungen anzeigen lassen. Die Entwicklung hat dafür einen Entwurf vorgelegt, aber noch keinen freigegebenen Versionsstand ausgeliefert. Bitte behandeln Sie diesen Vorschlag nicht als bereits wirksame Sicherung in Version 2.0. Der neue Test soll auch prüfen, ob die Bedienung unter Zeitdruck tatsächlich verändert wird.

Die Klassenbegründung ist weiterhin in Bearbeitung. Ich bitte darum, weder unsere bisherige Arbeitshypothese noch das Organisationszertifikat als endgültigen Produktnachweis zu verwenden. Für den rechtlichen Vermerk können Sie festhalten, dass wir die Unterstützung diagnostischer Entscheidungen als Zweck prüfen und die möglichen Folgen einer Fehlentscheidung mit Fachleuten bewerten lassen.

Eine Einbindung in echte Befundungen ist durch den aktuellen Testvertrag nicht gestattet. Die Laborumgebung bleibt getrennt. Zum weiteren Termin melde ich mich nach der Abstimmung mit unserem Qualitätsmanagement. Ich kann heute noch keine Aussage machen, wann ein vollständiges Konformitätspaket für Ihre konkrete Konfiguration vorliegen wird.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Livia Knörlein

09_Testdaten_und_Kosten.xlsx

Bildspur synthetischer Labortest

Stand 09.10.2026. Blau: veränderbare Eingaben. Schwarz: Formeln.

Referenzgruppe	Serien	Marker gesetzt	Ohne Marker	Markeranteil
Referenz auffällig	4	3	1	75.0%
Referenz unauffällig	36	3	33	8.3%

Die Quotienten sind Testzählwerte. Sie belegen keine klinische Eignung für den Patienteneinsatz.

B6:B7: Anzahl synthetischer Serien nach vorab festgelegtem Referenzbefund.

C6: richtig markiert; D6: übersehen. C7: zusätzlich markiert; D7: ohne Marker.

40 Serien, davon 4 Referenzauffälligkeiten; keine repräsentative klinische Validierung.

Quelle: 03_Technischer_Fehlertest.pdf, 06_Testlabor_Chat.txt, 07_Klinische_Besprechung.docx.

Ein Wert von 0 bei leerer Testgruppe ist eine Rechenkonvention; die Gruppe ist dann nicht geprüft.

Die Tabelle entscheidet weder Hochrisikoeinstufung noch Ausnahme oder Produktfreigabe.

Bildspur Angebot für vier Monate

Stand 09.10.2026. Blau: veränderbare Eingaben. Schwarz: Formeln.

Position	Anzahl	Einzelpreis netto EUR	Perioden	Gesamt netto EUR
Testzugänge je Monat	6	240.00	4	5,760.00
Netzeinbindung	1	2,400.00	1	2,400.00
Schulungstermine	2	750.00	1	1,500.00
Netto gesamt				9,660.00
Umsatzsteuer				19% 1,835.40
Brutto gesamt				11,495.40

Kostenquelle: 11_Kostenangebot.pdf. Keine Bestellung, keine fällige Rechnung.

Monatliche Position: Anzahl mal Monatspreis mal Monate. Einmalige Positionen haben eine Periode.

Die Preise sind Angebotsdaten; eine Änderung der Eingaben ist nur eine eigene Rechenvariante.

Gesetzliche Anwendungsfristen, medizinische Validierung und Konformitätsbewertung werden nicht berechnet.

02_Produktbeschreibung.docx

Bildspur Funktionsstände und Zweck

Dr. Livia Knörlein | Bildspur Medizintechnik GmbH | Messweg 6 | 07318 Saalfeld

An das Klinikum Morgenhöhe, Dr. Hanno Wölfel, IT und Medizintechnik
Stand 22. September 2026, Projekt BS-2026-219

1 Archivfunktion 1 0

Bildspur 1.0 erkennt Dokumenttypen und führt vorhandene Untersuchungsbezeichnungen aus dem Archiv in einer Suchliste zusammen. Die trainierte Texterkennung wertet die Bildinhalte nicht diagnostisch aus. Der Dienst trifft keine Aussage über einen Befund und beeinflusst nicht die Reihenfolge der ärztlichen Befundung. Für die Darstellung diagnostischer Bilder verwendet die Klinik ihr gesondertes vorhandenes Befundsystem.

2 Bildassistenz 2 0

Die neue Version verarbeitet CT-Bildserien nach ihrer Rekonstruktion. Ein trainiertes Bildmodell kennzeichnet Bildabschnitte, in denen nach seinem Muster eine auffällige Veränderung vorliegen könnte. Die Standardansicht zeigt diese Abschnitte zuerst. Unmarkierte Bilder bleiben über die Schaltfläche Gesamtserie erreichbar. Die Funktion ist für die Unterstützung bei Verlaufskontrollen in der ambulanten radiologischen Routine vorgesehen. Ein ärztlicher Befund wird vom System nicht unterschrieben oder selbst versandt.

Das Produktteam bezeichnet die neue Darstellung intern als Komfortmodus. Die medizinische Zweckbeschreibung lautet gegenwärtig Unterstützung der ärztlichen Bewertung auffälliger Bildveränderungen. Diese Formulierungen werden von der Rechtsabteilung noch abgeglichen. Für 2.0 liegt keine abschließend unterzeichnete EU-Konformitätserklärung in diesem Projektordner. Der bisher übersandte Nachweis betrifft unser organisationsbezogenes Qualitätsmanagement, nicht die Freigabe dieser konkreten Funktion.

3 Noch offene Optionen

Das Vertriebsteam hat zusätzlich eine mögliche Notfallvariante ab 2027 angesprochen. Sie würde Untersuchungen anhand eines vermuteten akuten Befunds priorisieren. Diese Option ist weder Bestandteil der Testlizenz noch technisch aktiviert. Der jetzige Test findet mit 40 synthetischen Bildserien in einem vom Klinikbetrieb abgetrennten Laborbereich statt. Ein Zugriff auf aktuelle Patientenakten ist nicht eingerichtet.

Dr. Livia Knörlein
Produktverantwortliche

07_Klinische_Besprechung.docx

Besprechung zu Bildauswahl und Rückfallweg

Dr. Ottilie Wagenblast | Radiologie Klinikum Morgenhöhe | Hangblick 18 | 07318 Saalfeld

Besprechung am 7. Oktober 2026, 13:30 Uhr

Teilnehmende: Dr. Ottilie Wagenblast, Radiologie; Dr. Hanno Wölfel, IT; Berfin Degenhardt, Qualitätsmanagement; Dr. Livia Knörlein, Hersteller.

1 Beobachtung im Labor

Vierzig synthetische Serien wurden mit 2.0 geprüft. Vier Serien enthielten nach dem vorab festgelegten Referenzbefund eine auffällige Veränderung. Das Modell markierte drei davon und übersah im Fall S17 die entsprechende Bildfolge. Drei zusätzliche unauffällige Serien erhielten einen auffälligen Marker. Die Testgruppe leitete keine Behandlung daraus ab. Es wurden keine echten Patienten geschädigt oder untersucht.

Bei S17 war die vollständige Serie über eine zweite Schaltfläche erreichbar. Dr. Wagenblast konnte den Referenzbefund nach Öffnung der Gesamtserie nachvollziehen. Im ersten Testlauf hatten die Nutzer aber nur bei 28 von 40 Serien diese Gesamtansicht geöffnet. Eine verpflichtende technische Bestätigung der vollständigen Sichtung existiert noch nicht. Die Anleitung verlangt eine eigenständige ärztliche Befundung; ob der geplante Arbeitsablauf sie tatsächlich sicherstellt, bleibt zu prüfen.

2 Bedeutung der unterschiedlichen Angaben

Die Herstellerin erklärt, dass die Funktion keine Therapie anordne. Dr. Wagenblast weist darauf hin, dass eine dauerhaft ausgelassene Auffälligkeit dennoch die ärztliche Beurteilung beeinflussen könne. Wie schwer eine solche Folge im vorgesehenen Routineeinsatz werden könnte, ist medizinisch noch nicht bewertet. Die klinische Leiterin möchte vor einer Einführungsentscheidung eine dokumentierte Gefährdungsanalyse und eine eindeutige Anleitung erhalten.

3 Noch keine Einführung

Dr. Wölfel bestätigt, dass das Testnetz keinen Zugriff auf den Produktivviewer hat. Der Hersteller soll den Vorschlag für eine neue Standardsicht liefern, in der zunächst alle Bilder und erst anschließend die Markierungen erscheinen. Die Klinik hat diesen Vorschlag noch nicht abgenommen. Der Beschaffungswunsch für Januar 2027 ist vorläufig; eine produktive Freigabe wurde nicht erteilt.

Die geplante Notfallpriorisierung wurde nur als spätere Option angesprochen. Die Teilnehmer sind sich einig, dass sie nicht stillschweigend in die jetzige Prüfung einbezogen werden darf. Die dafür benötigten rechtlichen und technischen Nachweise wären gesondert zu behandeln.

10_Stellungnahme_Arbeitsentwurf.docx

Arbeitsentwurf zum Produktpfad von Bildspur

Berfin Degenhardt | Klinikum Morgenhöhe | 8. Oktober 2026

1 Auftrag und Gegenstand

Dieser Entwurf bereitet eine interne Entscheidung über Bildspur 2.0 vor. Die Archivfunktion 1.0 und die noch nicht beauftragte Notfalloption müssen davon getrennt bleiben. Das Klinikum benötigt eine begründete Prüfung, ob der vorgesehene Einsatz einen Hochrisikopfad der KI-Verordnung eröffnet. Ein CE-Zeichen oder eine rechtliche Freigabe wird mit diesem Entwurf nicht erzeugt.

2 Bisherige Tatsachen

Die Herstellerin beschreibt die neue Funktion als Unterstützung der ärztlichen Bewertung von CT-Bildern, verwendet aber zugleich den Ausdruck Komfortmodus. Der Laborversuch zeigt eine nicht markierte Auffälligkeit bei S17. Die Gesamtserie blieb zugänglich, wurde jedoch nicht in allen Testvorgängen geöffnet. Welche Gesundheitsfolgen ein entsprechendes Übersehen im späteren Routineeinsatz haben könnte, ist bislang nicht schriftlich beurteilt.

Die Produktklasse und der einschlägige Weg der vorgeschriebenen Konformitätsbewertung sind offen. Der Hersteller hält eine bestimmte Klasse für wahrscheinlich, hat seine vollständige Begründung aber noch nicht vorgelegt. Das organisationsbezogene Qualitätsmanagementdokument benennt keine Freigabe der Version 2.0. Der Beschaffungsordner enthält daher noch keinen vollständigen Produktnachweis.

3 Auszuarbeitende Prüfung

Die Rechtsberatung soll beide Voraussetzungen des Artikels 6 Absatz 1 und die aktuellen Absätze 1a bis 1c anhand der Belege getrennt prüfen. Insbesondere ist zu erläutern, wie die behauptete nicht sicherheitsrelevante Unterstützung und die mögliche Gefährdung bei Ausfall oder Fehlfunktion zueinander stehen. Eine allgemeine vorbereitende Funktion darf nicht ohne Prüfung als Ausnahme für jedes Produkt behandelt werden.

Zusätzlich soll geklärt werden, ob der tatsächliche Routineeinsatz einen konkreten Anhang-III-Tatbestand erfüllt. Die nur diskutierte Notfalloption darf nicht als aktivierter Funktionsbestand zugrunde gelegt werden. Für den späteren Einsatz ist ein normbezogener Zeitplan erforderlich. Eine noch ausstehende Anwendung einzelner KI-Pflichten ersetzt keine Untersuchung bereits geltender medizinproduktrechtlicher oder sonstiger Anforderungen.

4 Nächste Dokumente

Der Einstufungsvermerk soll die offenen technischen und medizinischen Fragen präzise benennen. Ein getrenntes Schreiben an die Herstellerin soll Zweckbestimmung, Klassenbegründung, vorgeschriebenen Bewertungsweg, Version und Nachweisumfang anfordern. Die Empfehlung zum Starttermin wird erst nach den entscheidenden Antworten ergänzt. Der derzeitige Entwurf ist intern, unvollständig und nicht zur Übersendung als behördliche Erklärung vorgesehen.

03_Technischer_Fehlertest.pdf

Bildspur Laborbeobachtung S17

Klinikum Morgenhöhe | Testlabor | Bericht vom 5. Oktober 2026

1 Prüfumgebung

Der Test verwendet 40 synthetische CT-Serien mit einem vorab festgelegten Referenzbefund. Die Serien sind weder Bilder wirklicher Patienten noch eine repräsentative klinische Validierungsstichprobe. Der Versuch prüft die Darstellung und die Reaktion auf ausgewählte Bildmuster. Seine Kennzahlen dürfen nicht als Nachweis einer allgemeinen diagnostischen Leistungsfähigkeit verwendet werden.

2 Beobachtung S17

Die Referenzbeschreibung enthält eine auffällige Veränderung in einer hinteren Bildfolge. Version 2.0 erzeugte dort keinen Marker. In der Standardansicht waren zuerst andere markierte Bildbereiche sichtbar. Nach Auswahl der Gesamtserie konnte Dr. Wagenblast die betreffende Folge öffnen. Der technische Fehler lag daher nicht in einer vollständigen Löschung des Bildmaterials. Welche Eingabeschritte oder Modellmerkmale zum fehlenden Marker führten, wurde noch nicht untersucht.

Im geplanten Arbeitsablauf soll jede Ärztin und jeder Arzt die vollständige Serie eigenständig befunden. Im Test ist das nur für 28 von 40 Vorgängen im Viewer protokolliert. Die übrigen zwölf Einträge belegen keine vollständige Öffnung im Testfenster. Ob andere Wege genutzt wurden, ist nicht erfasst. Für eine Einführung wird ein überprüfbarer Ablauf benötigt; die bloße Zugänglichkeit beweist keine tatsächliche Sichtung.

3 Weiteres Vorgehen

Die Entwickler erhalten den synthetischen Datensatz und die Ereignisprotokolle im vereinbarten Testbereich. Der Zugriff auf echte Patientendaten wird dadurch nicht eröffnet. Ein neuer Test muss dieselben Ausfallbedingungen und den vorgeschlagenen Rückfallweg erfassen. Bis zu dessen Auswertung bleibt der Befund S17 als offener Fehler im Projekt bestehen.

05_Herstellerstand_Produktrecht.pdf

Stand der Unterlagen für Bildspur 2 0

Dr. Livia Knörlein | Bildspur Medizintechnik GmbH | 6. Oktober 2026

An das Klinikum Morgenhöhe
Bezug BS-2026-219

1 Medizinische Zweckbestimmung

Unser derzeitiger Entwurf der Zweckbeschreibung nennt die Unterstützung ärztlicher diagnostischer Entscheidungen bei radiologischen Verlaufskontrollen. Die interne Bezeichnung Komfortmodus ist nicht als eigenständige regulatorische Zweckbestimmung gedacht. Die Rechtsabteilung prüft gegenwärtig, welche medizinproduktrechtliche Klasse sich aus den vorgesehenen Entscheidungen und ihren möglichen Folgen ergibt. Im Projektgespräch wurde Klasse IIa als Arbeitshypothese genannt; eine abschließende Begründung ist damit nicht verbunden.

2 Bewertungsweg

Wir prüfen insbesondere die Software-Regel 11 und den hieraus folgenden Bewertungsweg. Die bislang an Sie gesandte Darstellung unseres Qualitätsmanagements betrifft die Organisation. Sie ersetzt keine Bescheinigung einer benannten Stelle für die neue Bildassistenz. Eine verbindliche Erklärung, dass gerade Version 2.0 von einem abgeschlossenen Verfahren erfasst sei, können wir zum heutigen Datum nicht abgeben. Die genaue Verfahrenszuordnung und ein möglicher Antrag werden noch bearbeitet.

3 Angebotene Zusammenarbeit

Wir werden die vollständige Klassenbegründung, den vorgesehenen Verfahrensweg und die aktuelle Gebrauchsanleitung nachreichen. Die medizinische Beurteilung möglicher Folgen eines übersehenen Bildbefunds bedarf der fachlichen Ergänzung. Die Unterschrift einer Ärztin oder eines Arztes unter einem späteren Befund ist aus unserer Sicht ein wichtiger Kontrollschritt, beantwortet aber nicht alle technischen Fragen des Ausfallpfads.

Die Notfallpriorisierung ist eine separate Entwicklung. Der Laborvertrag mit Ihrer Klinik enthält diese Funktion nicht. Bis zu einer schriftlichen Erweiterung dürfen die Testzugänge nicht für die Reihenfolge akuter Notfalluntersuchungen eingesetzt werden.

Dr. Livia Knörlein

11_Kostenangebot.pdf

Angebot für die Fortführung des Bildspur Tests

Bildspur Medizintechnik GmbH | Angebot BS-26-311 | 7. Oktober 2026

An das Klinikum Morgenhöhe, Hangblick 18, 07318 Saalfeld

1 Leistungsumfang und Preis

Für sechs Testzugänge über vier Monate beträgt das Entgelt je Zugang und Monat 240,00 EUR netto. Daraus ergeben sich 5.760,00 EUR netto. Für die Einbindung in das abgetrennte Testnetz werden einmalig 2.400,00 EUR netto angeboten. Zwei Schulungstermine kosten jeweils 750,00 EUR netto, zusammen 1.500,00 EUR netto. Die Nettosumme beträgt 9.660,00 EUR. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer kommen 1.835,40 EUR hinzu; der Bruttobetrag lautet 11.495,40 EUR.

Dies ist ein unverbindlicher Kalkulationsstand für die Entscheidung des Klinikums und keine Rechnung. Eine Bestellung ist noch nicht erfolgt. Die Durchführung einer vollständigen klinischen Validierung und die gegebenenfalls erforderliche Mitwirkung einer benannten Stelle sind im Preis nicht enthalten. Dafür werden Umfang und Aufwand erst nach Festlegung der endgültigen Zweckbestimmung vereinbart.

2 Technische Abgrenzung

Die Testzugänge erlauben keinen Zugriff auf den Produktivviewer und keinen Versand medizinischer Befunde. Der Hersteller unterstützt die Untersuchung der beobachteten Fehler mit synthetischen Serien. Eine Änderung der Darstellung, die sämtliche Originalbilder vor den Markierungen zeigt, soll gesondert angeboten werden. Die Klinik muss darüber entscheiden, bevor ein entsprechender Entwicklungsauftrag ausgelöst wird.

Die Notfalloption ist nicht enthalten. Aus der Laufzeit dieses Angebots folgt keine Aussage über gesetzliche Übergangsfristen oder eine Erlaubnis zum Patienteneinsatz. Ansprechpartnerin für eine Rückfrage ist Dr. Livia Knörlein unter livia.knoerlein@bildspur.example.